Ospedale San Leonardo di Poggiorosso
Dipartimento Chirurgico - Area Traumatologica
S.O.C. Ortopedia e Traumatologia
Direttore: Dott. Lapo Guidotti

Via Ciliegiole 97
51100 Pistoia
Segreteria 0573 351722

LETTERA DI DIMISSIONE

Ricovero urgente per trauma - infortunio sul lavoro

DATI DEL PAZIENTE

Paziente:	**Hoxha Arben**
Nato il:	**03/12/1983 in Albania**
Cittadinanza:	**albanese**
C.F.:	**HXHRBN83T03Z100A**
Domicilio:	**Via Pistoiese 455, Prato**
Recapito:	**fratello Ilir Hoxha, +39 328 774 5160**

N. ricovero: 2024-PT-0081452 Ingresso: 08/07/2024 Dimissione: 19/07/2024

N. ricovero: 2024-PT-0081452

Al Medico Curante

Gentile Collega,
Il sig. Arben Hoxha, muratore dipendente della ditta Edilnova Costruzioni S.r.l., è giunto alla nostra osservazione l'8 luglio 2024 in seguito a caduta accidentale da impalcatura (altezza circa 2,5 m) durante l'attività lavorativa. È stato redatto in Pronto Soccorso il certificato di infortunio sul lavoro INAIL n. INAIL-24-PT-338120.

ANAMNESI

Anamnesi patologica remota negativa. Non assume farmaci. Allergia ai FANS (angioedema nel 2019). Fumatore di circa 10 sigarette/die. Comunica in italiano in modo adeguato; per il consenso informato è stato comunque presente il fratello, sig. Hoxha.

DIAGNOSI ALL'INGRESSO

Frattura pluriframmentaria del pilone tibiale destro (tipo III sec. Rüedi-Allgöwer, AO 43-C2) con frattura associata del perone distale. Contusione del polso sinistro senza lesioni ossee.

INTERVENTI E PROCEDURE

Data	Procedura	Operatori
08/07/2024	Riduzione e stabilizzazione con fissatore esterno a ponte in attesa della risoluzione dell'edema dei tessuti molli	Dott. Niccolò Bartolini
15/07/2024	Rimozione del fissatore esterno, riduzione cruenta e osteosintesi con placca anatomica mediale e placca peroneale	Dott. Niccolò Bartolini; anestesia: spinale

DECORSO

Decorso post-operatorio regolare, ferite chirurgiche in ordine, non segni di sindrome compartimentale. La TC di controllo del 16/07/2024 ha documentato una buona riduzione della superficie articolare. Profilassi antitrombotica con enoxaparina 4000 UI e profilassi antibiotica perioperatoria con cefazolina 2 g. Il pz. ha iniziato la mobilizzazione con il fisioterapista Giulia Mencarelli: deambulazione con due bastoni antibrachiali senza carico sull'arto inferiore destro. Emoglobina alla dimissione 12,8 g/dL.

DIAGNOSI DI DIMISSIONE

Frattura del pilone tibiale destro trattata con osteosintesi; frattura del perone distale destro trattata con osteosintesi. Infortunio sul lavoro.

TERAPIA ALLA DIMISSIONE

Farmaco	Dose	Orari	Note
Enoxaparina 4000 UI s.c.	1 fl	ore 20	per 35 giorni complessivi
Paracetamolo 1000 mg	1 cpr	ogni 8 ore	al bisogno; NON assumere FANS
Tramadolo 50 mg	1 cpr	sera	al bisogno, per dolore intenso
Colecalciferolo 10.000 UI	30 gocce	settimanale	per 3 mesi

INDICAZIONI E CONTROLLI

Arto inferiore destro in scarico completo per 6 settimane, poi carico progressivo secondo indicazione dell'ortopedico. Medicazione e rimozione dei punti presso il nostro ambulatorio a 12 giorni dall'intervento. Controllo clinico-radiografico a 6 settimane il 28/08/2024 (prenotazione CUP-PT-24-556017). Prognosi INAIL: 90 giorni salvo complicazioni; il datore di lavoro, Edilnova Costruzioni S.r.l., riceverà la certificazione di prosecuzione tramite il medico curante.

Il Dirigente Medico

Dott. Niccolò Bartolini

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Dott. Niccolò Bartolini
Ordine Medici PT n. 2593

Pistoia, 19-07-2024

Il Direttore S.O.C.

Visto

Dott. Lapo Guidotti